TÓM TẮT ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

1. TÊN SẢN PHẨM

SKYVaricella Inj. Bột đông khô và dung dịch hồi chỉnh dùng để pha.

Varicella Virus Vaccine (live) [Oka/SK]

2. ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG

1 liều 0,5ml vắc xin sau khi hồi chỉnh có chứa:

Thành phần hoạt chất:

Vi rút varicella-zoster sống, giảm độc lực[1], chủng Oka/SK ≥ 2,400 PFU

[1] Sản xuất trên dòng tế bào lưỡng bội người (MRC-5)

[2]PFU: Plaque Forming Unit

Vắc xin có thể còn một lượng nhỏ neomycin. Xem mục 4.3 và 4.4.

Để biết thành phần đầy đủ, xem mục 6.1.

3. DẠNG BÀO CHẾ

Bột đông khô kèm theo dung dịch hồi chỉnh dùng để pha vắc xin.

Viên đông khô màu trắng đựng trong lọ thủy tinh trong suốt không màu. Sau khi hồi chỉnh, vắc xin là một hỗn dịch vàng nhạt hoặc không màu.

Dung dịch hồi chỉnh có dạng trong suốt, không màu.

4. ĐẶC TÍNH LÂM SÀNG

4.1. Chỉ định

Phòng bệnh thủy đậu cho trẻ em từ 12 tháng tuổi đến 12 tuổi.

4.2. Cách dùng và liều dùng

Liều dùng

Trẻ từ 12 tháng tuổi đến 12 tuổi

Một liều đơn 0,5ml được tiêm dưới da.

Chưa xác định được có cần tiêm liều nhắc lại hay không (xem mục 4.4)

Trẻ dưới 12 tháng tuổi

Chưa có số liệu nào về an toàn và hiệu quả của SKYVaricella Inj. khi sử dụng cho trẻ dưới 12 tháng tuổi.

Cách dùng

SKYVaricella Inj. được tiêm dưới da vào mặt ngoài của cánh tay (vùng cơ delta). Không được tiêm SKYVaricella Inj. vào mạch máu hoặc tiêm bắp.

Xem mục 6.6 hướng dẫn hồi chỉnh vắc xin trước khi tiêm.



4.3. Chống chỉ định

1) Những người có tiền sử phản ứng quá mẫn với gelatin hoặc bất cứ thành phần nào của vắc xin SKYVaricella Inj.
2) Những người có tiền sử phản ứng phản vệ với kháng sinh neomycin (vắc xin đã hồi chỉnh còn một lượng nhỏ kháng sinh neomycin).
3) Những người đang bị suy giảm miễn dịch tiên phát hoặc mắc phải do những tình trạng như bệnh bạch cầu cấp tính hoặc mãn tính; u lympho; các bệnh lý khác ảnh hưởng đến tủy xương hoặc hệ bạch huyết; ức chế miễn dịch do HIV/AIDS; và suy giảm miễn dịch tế bào.
4) Những người đang được điều trị bằng các liệu pháp ức chế miễn dịch (SKYVaricella Inj. có thể gây phát bệnh ở những người bị suy giảm miễn dịch hay đang điều trị bằng liệu pháp ức chế miễn dịch, do đây là vắc xin vi rút thủy đậu sống, giảm độc lực).
5) Những người nhiễm lao thể hoạt động chưa được điều trị.
6) Phụ nữ có thai hoặc nghi ngờ đang mang thai (xem mục 5. *Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú*).
7) Những người đang bị sốt do mắc các bệnh lý đường hô hấp hoặc sốt do các nguyên nhân nhiễm khuẩn khác.

4.4. Thận trọng khi dùng thuốc

1) Như với các vắc xin khác, phản ứng phản vệ/sốc phản vệ có thể xảy ra khi tiêm vắc xin SKYVaricella. Các biện pháp điều trị thích hợp, bao gồm epinephrine (1:1000) cần phải sẵn sàng để sử dụng khi cần.
2) Cân nhắc việc hoãn tiêm nếu người được tiêm bị ốm cấp tính (VD: sốt trên 38°C)
3) Chưa rõ ràng về thời gian bảo vệ ngừa nhiễm thủy đậu sau khi tiêm vắc xin SKYVaricella.
4) Chưa có đánh giá về hiệu quả của việc tiêm nhắc lại. Chưa xác định được việc có cần liều tiêm nhắc lại hay không.
5) Giống với các vắc xin khác, việc tiêm phòng vắc xin SKYVaricella không bảo vệ được cho tất cả các đối tượng được tiêm.

6) Lây truyền vi rút vắc xin sau tiêm vắc xin SKYVaricella Inj. chưa được báo cáo. Tuy nhiên, một nghiên cứu sau cấp phép của vắc xin thuỷ đậu khác đã khẳng định có thể xảy ra việc lây truyền vi rút vắc xin rất hiếm gặp khi có tiếp xúc giữa người được tiêm khỏe mạnh có phát ban dạng thủy đậu và người cảm nhiễm khoẻ mạnh và việc lây nhiễm vi rút vắc xin từ người được tiêm phòng không gây phát ban dạng thủy đậu ở người cảm nhiễm. Tuy vậy, người được tiêm phòng nên tránh tiếp xúc gần với những người có nguy cơ cao bị lây nhiễm trong vòng 6 tuần sau tiêm. Trong trường hợp không thể tránh được việc tiếp xúc với người có nguy cơ cao thì cần cân nhắc giữa nguy cơ lây nhiễm vi rút từ vắc xin với việc mắc và lây nhiễm vi rút thuỷ đậu chủng hoang dại. Những đối tượng cảm nhiễm có nguy cơ cao bao gồm:
    - Người suy giảm miễn dịch.
    - Phụ nữ có thai không có tiền sử mắc bệnh thủy đậu hoặc kết quả xét nghiệm cho thấy chưa bị lây nhiễm trước đó.
    - Trẻ sơ sinh mà mẹ không có tiền sử mắc bệnh thủy đậu hoặc kết quả xét nghiệm cho thấy chưa bị lây nhiễm trước đó.

4.5. Tương tác với thuốc khác và các dạng tương tác khác

1) Chưa có số liệu về việc tiêm đồng thời vắc xin varicella này và các vắc xin khác. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Tế giới (WHO) khuyến cáo rằng vắc xin varicella có thể được tiêm đồng thời với vắc xin khác trong chương trình tiêm chủng định kỳ cho trẻ em. Trừ khi tiêm đồng thời với các vắc xin vi rút sống khác (sởi, MR, MMR), cần tiêm các vắc xin khác với khoảng cách tối thiểu là 28 ngày.
2) Sau khi truyền máu hoặc plasma, hoặc tiêm truyền immune globulin hay varicella-zoster immune globulin, chỉ tiêm vắc xin SKYVaricella Inj. sau khoảng thời gian tối thiểu là 3-11 tháng tùy theo loại và số liều máu hay immunoglobulin tiêm truyền.
3) Không được tiêm đồng thời vắc xin SKYVaricella Inj. với immune globulin bao gồm cả immune globulin varicella-zoster. Cũng như vậy, không tiêm immune globulin bao gồm cả immune globulin varicella-zoster 2 tháng sau khi tiêm vắc xin trừ khi việc tiêm có tác dụng hơn vắc xin. (unless its use outweighs the benefit of vaccination).
4) Do hội chứng Reye đã được báo cáo sau khi sử dụng salicylates trong một trường hợp nhiễm vi rút varicella-zoster hoang dại, người được tiêm phải tránh sử dụng salicylates trong 6 tuần sau khi tiêm vắc xin.

4.6. Khả năng sinh sản, phụ nữ có thai và cho con bú

Khả năng sinh sản

Chưa có số liệu nào về tác động của vắc xin lên khả năng sinh sản. Các nghiên cứu trên động vật cho thấy khả năng sinh sản của động vật giống cái không bị ảnh hưởng. Khả năng sinh sản của động vật giống đực chưa được đánh giá.

Phụ nữ có thai

Chưa đánh giá được tính an toàn của vắc xin SKYVaricella trên phụ nữ có thai. Chưa quan sát thấy các phản ứng trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và gây độc ở các nghiên cứu trên động vật. Tuy nhiên, không nên tiêm vắc xin SKYVaricella cho phụ nữ có thai do vi rút Varicella hoang dại (nhiễm theo đường tự nhiên) đôi khi gây hại cho thai nhi. Hơn thế nữa, nên tránh có thai trong vòng 3 tháng sau khi tiêm vắc xin (xem mục 4.3).

Phụ nữ cho con bú

Chưa biết rõ vi rút varicella sống giảm độc lực có bị bài tiết vào sữa mẹ hay không. Tuy nhiên, do một số vi rút có được bài tiết vào sữa mẹ, cần cân nhắc khi tiêm vắc xin SKYVaricella cho người mẹ đang cho con bú.

4.7. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của vắc xin lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

4.8. Phản ứng không mong muốn

Tóm tắt các hồ sơ về tính an toàn

Trong các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn II và III, vắc xin SKYVaricella Inj. được tiêm cho 365 đối tượng khỏe mạnh độ tuổi từ 12 tháng đến 12 tuổi. Thông tin về tính an toàn của các phản ứng không mong muốn liên quan đến thuốc được thu thập trong vòng 7 ngày sau khi tiêm, trong khi nổi ban dạng thủy đậu và các phản ứng không liên quan đến thuốc được thu thập trong vòng 6 tuần sau khi tiêm.

Tóm tắt về các phản ứng không mong muốn

1) Tính an toàn của vắc xin SKYVaricella Inj. được đánh giá trên 365 đối tượng từ 12 tháng tuổi đến 12 tuổi, trong đó 167 đối tượng (chiếm 45,75%) gặp các phản ứng không mong muốn.
2) Phản ứng tại chỗ: Đau/nề nhẹ tại chỗ tiêm, đỏ, mảng cứng có thể xảy ra.
3) Phản ứng toàn thân: Sốt, quấy khóc/kích thích, khó ngủ/bứt rứt, đôi khi xảy ra phản ứng toàn thân như mệt mỏi/khó chịu và đau đầu sau khi tiêm.

① Các phản ứng không mong muốn (tại chỗ và toàn thân) có liên quan đến thuốc sau khi tiêm vắc xin SKYVaricella được tóm tắt trong bảng sau.

	Thử nghiệm lâm	Thử nghiệm lâm

		sàng giai đoạn II N=114	sàng giai đoạn III N=251
Phản ứng tại chỗ	Đau/nề nhẹ	14,04%	20,32%
	Ban đỏ/đỏ	17,54%	32,67%
	Cứng/sưng phồng	6,14%	15,54%
Phản ứng toàn thân	Sốt	7,02%	7,97%
	Ngủ lơ mơ/mệt mỏi	5,26%	7,57%
	Đau đầu	1,75%	2,39%
	Quấy khóc/kích thích	11,40%	11,95%
	Mệt mỏi/khó chịu	0,00%	12,90%

1. Phản ứng không mong muốn được báo cáo theo hệ thống thu thập dữ liệu được thiết lập trước và được ghi nhận trong 7 ngày sau khi tiêm.

2. Phản ứng mệt mỏi/khó chịu được ghi nhận ở trẻ từ 5 tuổi trở lên (Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn II N=0/9 và Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III N=4/31).

② Các phản ứng không mong muốn không liên quan đến thuốc được báo cáo ở 16 đối tượng (4,38%) trong số 365 đối tượng từ 12 tháng đến 12 tuổi trong vòng 42 ngày sau khi tiêm vắc xin SKYVaricella Inj. Phản ứng thường thấy nhất được báo cáo là rối loạn mô ở da và dưới da trên 7 đối tượng (1,92%) với 8 ca bệnh được báo cáo và biểu hiện nhiễm trùng/viêm nhiễm trên 6 đối tượng (1,64%) với 6 ca bệnh được báo cáo. Tất cả các đối tượng đều khỏi bệnh và không để lại di chứng.

Biểu hiện của các phản ứng không mong muốn ít gặp (≥0,1 và <5%) bao gồm:

-Rối loạn tiêu hóa: Nôn, tiêu chảy

-Bị nhiễm trùng/viêm nhiễm: viêm dạ dày ruột, viêm mũi họng, viêm đường hô hấp trên.

-Rối loạn chung và tại chỗ tiêm: nổi ban đỏ chỗ tiêm.

-Rối loạn trao đổi chất và dinh dưỡng: Chán ăn.

-Rối loại mô ở da và dưới da: nổi ban đỏ, phát ban, phát ban dạng mụn nước.

③ Xảy ra 7 phản ứng không mong muốn nghiêm trọng trong vòng 26 tuần sau khi tiêm ở 6 đối tượng (1,64%) trong số 365 đối tượng nghiên cứu (2 ca viêm tiểu phế quản, 1 ca viêm tai giữa cấp tính, 1 ca viêm phổi, 1 ca viêm đường hô hấp trên, 1 ca viêm phổi do vi rút hợp bào đường hô hấp, và 1 ca bỏng nhiệt). Theo báo cáo thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III, tất cả các phản ứng không mong muốn nghiêm trọng này đều được khẳng định là

không liên quan đến vắc xin SKYVaricella Inj.

④ Phát ban dạng thủy đậu được báo cáo ở 6 đối tượng (1,64%) trong số 365 đối tượng nghiên cứu trong vòng 42 ngày sau khi tiêm vắc xin trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III, 5 ca phát ban dạng thủy đậu toàn thân và 1 ca phát ban tại chỗ tiêm. 4 đối tượng phát ban dạng thủy đậu toàn thân và 1 đối tượng phát ban dạng thủy đậu tại chỗ tiêm được lấy mẫu tại vị trí tổn thương và làm thử nghiệm PCR. Kết quả cho thấy 5 đối tượng đều nhiễm vi rút varicella-zoster, nhưng type vi rút (chủng hoang dại hay chủng Oka/SK) thì chưa xác định được. 2 ca phát ban toàn thân được khẳng định là không có liên quan đến vắc xin SKYVaricella Inj., 3 ca phát ban toàn thân và 1 ca phát ban tại chỗ còn lại chưa loại trừ được mối liên quan với việc tiêm vắc xin SKYVaricella Inj.

4.9. Quá liều

Chưa có đánh giá trên lâm sàng nào về việc tiêm quá liều vắc xin SKYVaricella Inj.

5. ĐẶC TÍNH DƯỢC HỌC

5.1. Dược lực học

Nhóm dược lý: Vắc xin vi rút – vi rút thủy đậu.

Mã ATC: J07BK01

Cơ chế hoạt động:

Bệnh thủy đậu phát sinh do việc nhiễm vi rút varicella-zoster (VZV). SKYVaricella Inj. là vắc xin vi rút varicella-zoster sống, giảm độc lực (chủng Oka/SK) tạo nên miễn dịch kháng lại việc nhiễm vi rút thủy đậu.

Kết quả sinh miễn dịch

Hiệu quả (tính sinh miễn dịch) của SKYVaricella Inj. được đánh giá thông qua một nghiên cứu lâm sàng đa quốc gia, ngẫu nhiên, mù kép, đối chứng có kiểm soát, song song trên trẻ em khỏe mạnh từ 12 tháng đến 12 tuổi. Các phân tích sinh miễn dịch ban đầu được thực hiện trên 458 đối tượng theo đề cương (PPS) và không thua kém dựa trên tỉ lệ chuyển đổi huyết thanh được chứng minh bằng thử nghiệm FAMA (kháng thể huỳnh quang với kháng nguyên màng). Kết quả thử nghiệm FAMA thực hiện trong nghiên cứu lâm sàng giai đoạn III được thể hiện trong bảng dưới đây.

		Nhóm tiêm SKYVaricella Inj. (N=228)	Nhóm so sánh (N=230)

Kháng thể nền	GMT±GSD	1,37 ± 2,62	1,22 ± 1,97
	Khoảng tin cậy 95% của GMT	[1,21; 1,55]	[1,11; 1,33]
6 tuần sau tiêm	GMT±GSD	103,15 ± 2,87	54,22 ± 3,32
	Khoảng tin cậy 95% của GMT	[89,89; 118,36]	[46,39; 63,38]
6 tuần sau tiêm (kháng thể nền)	GMR±GSD	75,42 ± 3,77	44,58 ± 3,69
	Khoảng tin cậy 95% của GMR	[63,42;89,69]	[37,63;52,81]
Tỉ lệ chuyển đổi huyết thanh*	% (n/N)	99,53 (211/212)	96,38 (213/221)
	Khoảng tin cậy 95% của tỉ lệ chuyển đổi huyết thanh	[97,40; 99,99]	[92,99; 98,42]
	Khác biệt về tỉ lệ giữa 2 vắc xin	3,15	
	Khoảng tin cậy 95% của sự khác biệt về tỉ lệ giữa 2 vắc xin	[0,52; 5,78]	
* Tỉ lệ chuyển đổi huyết thanh: Tỉ lệ đối tượng chuyển từ huyết thanh âm tính (với hiệu giá kháng thể VZV theo thử nghiệm FAMA < 1,4) trước khi tiêm thành huyết thanh dương tính (với hiệu giá kháng thể VZV theo thử nghiệm FAMA ≥ 1,4)			

5.2. Dược động học

Không áp dụng.

5.3. Thông tin tiền lâm sàng

Các kết quả nghiên cứu tính an toàn dược lý (hệ thống tim mạch, hô hấp và hệ thần kinh), nghiên cứu về độc tính trên liều đơn và liều nhắc lại, và nghiên cứu về độc tính đối với khả năng sinh sản cho thấy không có phản ứng không mong muốn tiềm tàng nào có thể xảy ra trên người.

6. CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC HỌC

6.1. Thành phần tá dược

Dạng bột:

Sucrose

Hydrolyzed gelatin

Urea

Monosodium glutamate

Disodium edtate

L-cysteine

Glycine

Sodium dihydrogen phosphate dihydrate

Disodium phosphate dodecahydrate

Sodium chloride

Potassium chloride

Sodium hydroxide

Dạng dung dịch:

Nước pha tiêm.

6.2. Tương kỵ

Vắc xin không được trộn lẫn với các thuốc khác.

Vắc xin không được hồi chỉnh với các thuốc khác trừ các trường hợp nêu trong mục 6.6.

6.3. Hạn dùng

24 tháng.

6.4. Các cảnh báo đặc biệt về bảo quản

Bảo quản lạnh ở 2°C – 8°C trong bao bì kín tránh ánh sáng.

Cả vắc xin đông khô và vắc xin đã hồi chỉnh đều phải tránh ánh sáng.

6.5. Tính chất và dung lượng của bao bì đóng gói

Bột đông khô

Viên đông khô màu trắng đựng trong một lọ thủy tinh loại I, có nút cao su (chlorobutyl rubber) và nút nhôm.

Dung dịch hồi chỉnh

Nước pha tiêm đựng trong lọ thủy tinh loại I có nút cao su (chlorobutyl rubber) và nút nhôm.

Vắc xin SKYVaricella Inj. được đóng gói như sau:

1) 1 hộp gồm 5 lọ vắc xin đông khô và 5 lọ dung dịch hồi chỉnh
2) 1 hộp gồm 10 lọ vắc xin đông khô và 10 lọ dung dịch hồi chỉnh

6.6. Cảnh báo đặc biệt về sử dụng và các cách xử lý

1) Hướng dẫn hồi chỉnh vắc xin

Để hồi chỉnh vắc xin, hút toàn bộ thể tích dung dịch hồi chỉnh trong lọ và bơm vào lọ vắc xin đông khô. Lắc nhẹ để hòa tan viên đông khô. Rút hỗn dịch vừa hồi chỉnh vào xi lanh và tiêm toàn bộ thể tích hỗn dịch này (tương đương 1 liều đơn 0,5ml) vào mặt ngoài của cánh tay (vùng cơ delta). Để tránh giảm công hiệu, vắc xin phải được tiêm ngay sau khi hồi chỉnh. Loại bỏ vắc xin đã hồi chỉnh nếu không được sử dụng trong vòng 30 phút.

2) Phải bảo quản vắc xin SKYVaricella Inj. trong tủ lạnh và hồi chỉnh ngay sau khi lấy từ tủ lạnh ra. Vắc xin phải được sử dụng ngay sau khi hồi chỉnh. Vắc xin đã hồi chỉnh không được để đông băng.

3) Phải sử dụng xi lanh và kim tiêm riêng cho mỗi mũi tiêm để tránh việc lây truyền bệnh. Kim tiêm đã sử dụng phải được loại bỏ theo cách thích hợp để tránh việc tái sử dụng.

7. CHỦ SỞ HỮU SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH SẢN PHẨM

SK bioscience Co., Ltd.
150, Saneopdanji-gil, Pungsan-eup,
Andong-si, Gyeongsangbuk-do,
Republic of Korea.

8. SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH SẢN PHẨM

1 (Ở Korea)

9. NGÀY CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH LẦN ĐẦU/GIA HẠN SỐ ĐĂNG KÝ

Cấp lần đầu: 04.6.2018.

10. NGÀY XEM XÉT LẠI BẢN TÓM TẮT ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

14.6.2019.